（二）室速

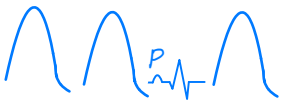
室性大多由冠心病引起
房性大多由二尖瓣狭窄导致的

1.心电图

①连续出现 3 个及其以上的宽大畸形 QRS 波（室早 plus）

室上性冲动夺取了一次心室控制权

②**特征：心室夺获、室性融合波**部分心室夺获(室上性冲动和心室异位起搏点一人一半)



③房室分离：P 波与 QRS 波无关，心室率明显快于心房率，心室率多 100-250 次/分

一种异位起搏点

不同异位起搏点



图 3-3-22　室性心动过速

A. Ⅱ导联可见一系列快速、宽大畸形的 QRS 波，QRS 波呈一种形态，RR 间期略不规则；B. V_1 导联 QRS 波呈不同形态，为多形性室速；C. V_1 导联 QRS 波群主波方向出现上、下交替性变换，为双向性室速。

宽QRS波心动过速的鉴别:

	逆向型的AVRT	室速
房早是否可以触发或终止它	✓	×
P波与QRS关系	1:1	无关(房室分离)
心室夺获、室性融合波	×	✓ ⭐
全导联QRS主波同向性	×	✓

2.室速的特殊类型

（1）尖端扭转型室速（多形性室速的特殊类型）

①病因：奎尼丁、**胺碘酮**、低钾、低镁等

美妞

②治疗：**补镁**。先天性长 QT 间期综合征用 β-R 拮抗剂

③心电图：QRS 波振幅与波峰呈周期性变化，**QT 间期延长，明显 U 波**（niu），心室率多 200-250 次/分

低钾血症→心肌细胞钾外流↓→复极化速度↓→APD(QT间期)↑　对浦肯野纤维影响最大

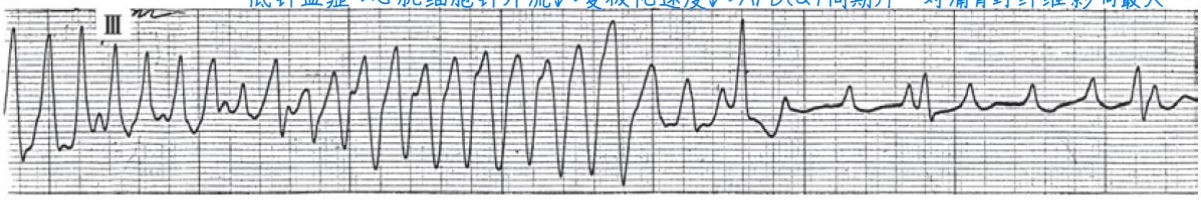


图 5-1-69　尖端扭转型室性心动过速

室性逸搏　20-40→60-110

（2）加速性室性自主心律（缓慢型室速）

①可见于急性心梗再灌注期间，多不治疗

VS 阵发性室上速:突发突止

②连续发生 3-10 个起源于心室的 QRS 波，心动过速的开始与终止呈渐进性（渐发渐止）元气大伤

十、房室传导阻滞

基本上心律失常这个章节都装永久起搏器
其他章节(如心肌梗死、心肌炎)导致的心律失常装临时起搏器

1.治疗

①一度房室阻滞、二度I型房室阻滞可见于正常人，无症状不治疗

②二度II型和三度房室阻滞出现心室率过慢或 **Adams-Stokes 心源性脑缺血综合征**时及早安置起搏器；不可逆者无论有无症状植入**永久起搏器**

③无起搏条件者阻滞部位在房室结**短期用阿托品**；任何部位的房室阻滞短期用异丙肾上腺素（不用于急性心梗）阿姨

迷走N在房室结最多

β1-R激动剂

β-R激动剂:多巴胺、多巴酚丁胺、异丙肾上腺素
强心　正性传导作用